REGISTRO CLINICO ELECTRONICO

EPICRISIS MEDICA

Paciente: GARRIDO MONTECINOS LISSETTE ANDREA

Edad actual: 22 A/ 3 M/ 14 D | **Edad al ingreso: 22 A/ 3 M/ 1 D** | **DAU:** | **Fecha ingreso hospitalización: 11.12.2025**

RUN: 21.387.731-3 | **N° Archivo: 1800671** | **Fecha De Egreso:**

Previsión / Tramo: FONASA B | **Días de Estada:**

ID: 2264032 || Orígen: SIRYC
Tipo de Atención: HOSPITALIZACIÓN
Tipo Registro: EPICRISIS
Fecha Registro: 24-12-2025 11:38:21

Nombre Profesional: SAEZ DEL RIO, VICTOR OSVALDO
Tipo Profesional: MEDICO CIRUJANO
Especialidad Médica: Medicina Interna

Unidad de Atención: UTI MEDICA
Sala: UCEGO / Cama: 3

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO

PRINCIPAL: T861 - FALLA Y RECHAZO DE TRASPLANTE DE RIÑÓN |

DIAGNÓSTICOS DE EGRESO

PRINCIPAL: T861 - FALLA Y RECHAZO DE TRASPLANTE DE RIÑÓN |

EPICRISIS MEDICA	
F. INGRESO UTI	11.12.25
APACHE II	12
PATOLOGIAS CRONICAS	
PATOLOGIAS CRONICAS *	ANTECEDENTES MORBIDOS: ERC etapa V en Peritoneodiálisis desde 2022 a 2025 por glomeruloenfritis por depósitos de C3/ Insuficiencia cardiaca con FE reducida 38%, CIA Qx: Tr renal donante vivo consanguíneo (27.09), CIA infancia (a los 4 años), biopsia renal 03/12 ALERGIAS: No MEDICAMENTOS: bisoprolol 5 mg cada 12. espiro 25 x1. tacrolimus 2.5 cada 12 horas, prednisona 5 mg al dia VO, micofenolato 360 mg cada 12 horas, cotrimoxazol forte L-M-V, furosemida 40 mg 1/2- 1/, EPO 2000 UI trisemanal. Cinacalcet 1 diario. HABITOS: Tabaco no OH no
EVOLUCION O COMENTARIO	

EVOLUCION O COMENTARIO *	Diagnósticos de Traslado a San Carlos HDOM: - ITU Bacteriémica por ERV en tto, en espera de Traslado a HDOM de su servicio de origen - Rechazo humoral renal agudo (Metilprednisolona 3 bolos + plasmaféresis 4 sesiones + RTX 1g) - Falla renal aguda no oligúrica sobre ERC, Cr queda en 2.4 / TFG 27 - Insuficiencia Cardiaca Fracción Reducida FEVI 38% sin etiología - Hipokalemia resuelta - CAD euglicémica resuelta - Trombopenia inducida por heparina resuelta. AM: ERC etapa V en Peritoneodiálisis desde 2022 a 2025 por glomeruloenfritis por depósitos de C3/ Insuficiencia cardiaca con FE reducida 38%, CIA. Qx: Tx renal donante vivo consanguíneo (27.09), CIA infancia (a los 4 años), biopsia renal 03/12 Paciente de 22 años con antecedente de Glomerulonefritis por C3? (solo óptica e inmuno Bp realizada Chillan , informada Dr Mendez). Estudio genético SHUa negativo (Centrogene). Se asume factor nefrítico (+) , pero no tiene estudio complemento.CYP3A5 metabolizador lento Insuficiencia cardiaca FE 38%. Se trasplanta donante vivo (padre) el 26.09, PRA 0% comparte 1 haplotipo. Se induce con simulec, inmunosupresión estándar. Buena evolución, descenso rápido de creatinina, con drenaje que queda varios días , se retira a las dos semanas. con descenso de creat 1,2 mg/dl al alta. Presenta niveles muy altos de tacrolimus con alza creatinina hasta 3,7 mg/dl que mejoro rápidamente al descender la dosis, en seguimiento por unidad de terapias personalizadas. Finalmente con dos meses y medio postrasplante nuevo ascenso de creat posterior a diarrea , se hospitaliza para Biopsia. Se realiza bp renal hace dos semanas por haber persistido con creat 2,0 . Se recibe pre informe con rechazo humoral activo , G1, capilaritis 1 , IFTA 5% , C4D negativo , SV40 negativo por lo que se hospitaliza el 11.12 para manejo. Exs de ingreso: 11.12 Crea 2.2 VFG 30 ml/min BUN 33 Uremia 71 Tacrolimus 9.23. Inicia el 13/12 Plasmaféresis, Gamaglobulina y metilprednisolona 500 mg iv. Recibiendo en total 4 plasmaféresis, una dosis total de 105 g de IGIV y 3 bolos de metilprednisolona 500 mg ev x 3. Además de su tratamiento crónico habitual, Durante la administración mantiene diuresis, cursa con CAD euglicémica que requiere BIC de insulina, logrando manejo precoz. El 13/12 luego de 2 PLEX + 3 dosis de IG requiere tx de crioprecipitado por hipofibrinogenemia, además se agrega candesartán. El 14/12 se ajusta prednisona oral. El 14/12 se instala CVC sin incidentes. El 15/12 requiere crioprecipitado nuevamente. Cursa con aumento de volumen en sitio de inserción de VV pero sin signos de flebitis, de todas formas se descarta tromboflebitis mediante eco doppler. Progresa con trombopenia que impresiona inducida por heparina, revierte al suspender por lo que desde esa fecha de mantiene con MAT. El 16/12 cursa con fiebre por lo que se realizan hemocultivos + EOC

	poco inflamatorio y UC, se inicia piperacilina/tazobactam. Durante hospitalización: se recibe inmunofluorescencia preinforme verbal sin depósitos, lo que descarta reproducción de enfermedad. Progresa con elevación de PI. El 17/12 HC 1/2 para CGP pares y cadenas cortas, se ajusta a linezolid. Por mal capital venoso se planteó inicialmente pasar a la segunda semana a antibiótico oral, pero finalmente se rescata HC + E. faecium con foco de injerto renal por lo que para llegada a tejido renal se ajusta a teicoplanina. Mejor creatinina lograda 1.59 posteriormente cursa con LRA sobre ERC en contexto de pielonefritis del injerto, ecografía descarta complicación local. Finalmente se decide suspender candesartan por su hubiera algún efecto hemodinámico , ya que creat volvió a quedar en 2,3 mg/dl . El día 22/12 recibe Rituximab 1g ev sin incidentes. Actualmente Estable, sin conflicto HDN ni ventilatorio AFebril, buena tolerancia oral, buen control metabólico, PCR baja 22.12 recibe Rtx 1g bien tolerado DIURESIS: 1350 cc 24 hrs / DEP 150 cc blandas / BH - 375 Exs 24.12; Hb 8.4, Hto 25.2%, GB 7600, PLT 196.000, Cr 2.4, TFG 27, BUN 31, ELP 135/4.2/103, PCR 0.65 En condiciones de continuar traslado a su hospital de origen para completar tto con teicoplanina vía hospitalización domiciliaria (Se entregára acá dosis para tto completo de TEICO)
MEDICAMENTOS Y DOSIS SUMINISTRADAS EN HOSPITALIZACION	
MEDICAMENTOS Y DOSIS SUMINISTRADAS EN HOSPITALIZACION *	Plasmaféresis 4 sesiones Gamaglobulina 105 g en 7 dosis. Piperacilina/tazobactam 3.375mg cada 6 horas por 2 días Linzolid 600 mg cad1 12 horas por 2 días Teicoplanina 400 mg dia (6/14) Tratamiento crónico habitual Tacrolimus según niveles Metiilprednisolona 500 mg ev x 3
RESULTADOS DE EXAMENES RELEVANTES Y PROCEDIMIENTOS	

RESULTADOS DE EXAMENES RELEVANTES Y PROCEDIMIENTOS *	20.12 PCR 3.99, SCrea 2.23, ELP 134/4.53/103, BUN 22, Uremia 47, Hb 8.2, Hto 24.4, R. Plaq 130.000, R. Blancos 4.800, GSV pH 7.37, HCO3 22.6, i-Ca 4.68 19.12 Hb 7.9 Leu 6.0 Plaq 108 SCr 1.83 BUN 16 ELP 133/4.42/104 Ca 7.8 P 2.1 Mg 1.4 Alb 2.9 pH 7.36 pCO2 35 HCO3 19.8 PCR 7.01. 17.12 Hb 8.5, Hto 25%, GB 9500, plaquetas 72.000 PCR 16 P 1.4 bajo, Mg 1.4 bajo Cr -, BUn 18 ELP 133/3.6/104, Alb 3.4, Cac 7.3, pH 7.39, Hco3 20 TTPA 33, Fibrinógeno 272, INR 1.27 16.12 Cr 1.67 VFG 42 BUN 24 Fibrinogeno 250 15.12 Cr 1.64 VFG 43 BUN 57 Fibrinogeno 146 Hb 6.3 14.12 tacrolimus 9.9, cetonemia 0.19(-) BUN 30 ELP 137/3.5/108 Crea 1.98 Fib 139 INR 1.1 pH 7.36 Bic 18 Ca i 3.9 Hb 7.5 Plquetas 123.000 GB 7100 MICROBIOLOGÍA 18/12 C. diff (-) 16/12 HC 1 de 2 (+) E. faecium resitente a vancomicina. 16/12 PVR (-) 16/12 Punta CVC (-) 16/12 UROC (+) E. faecium Ecocardiograma: 26.09 Ventrículo izquierdo de tamaño y grosor normal. Función sistólica moderadamente deprimida por hipokinesia difusa. FE 38%. Sin shunt intracardiaco Biopsia (preinforme) rechazo humoral activo , G1, capilaritis 1 , IFTA 5% , C4D negativo , SV40 negativo
INDICACIONES AL ALTA (FARMACOLOGICAS Y NO FARMACOLOGICAS)	
REPOSO	Relativo
REGIMEN ALIMENTARIO	Hiposódico
CONTROLES	En Poli Trasplante A HDOM San carlos vía móvil básico
INDICACIONES ADICIONALES	- Teicoplamina 320 mg al día EV (6 de 14) - Prednisona 5mg/día vo - Tacrolimus 2,0 mg (AM)/ 2.0 mg (PM) --> Hoy control NP, dejo orden - Myfortic 360 mg cada 12 horas VO - Bisoprolol 5 mg cada 12 horas VO velador - Espironolactona 25 mg dia VO - Cotrimoxazol forte L-M-V - Furosemida 40 mg: 1/2 al día vo - EPO 2000 UI trisemanal. - Cinacalcet 1 diario. - Bicarbonato de sodio 1 gr cada 8 hr vo - Precaución contacto - Se solicita Traslado a San Carlos por Gestión de Camas a HDOM, ambulancia básica. Realizo epicrisis para traslado HDOM san carlos

NO SE GENERARON RECETAS PARA ESTE EPISODIO

NO SE REGISTRARON NUEVAS PRESTACIONES Y ACCIONES PARA ESTE EPISODIO

NO SE GENERARON ORDENES DE IMAGENOLOGÍA PARA ESTE EPISODIO

NO SE GENERARON ORDENES DE LABORATORIO PARA ESTE EPISODIO

MED. VICTOR OSVALDO SAEZ DEL RIO